



Nuansa
Fajar
Cemerlang

INSTRUMEN RECOVERY PASIEN SKIZOFRENIA DI KOMUNITAS

Mamnuaah • Dwi Ernawati
Yuli Isnaeni



Instrumen *Recovery* Pasien Skizofrenia di Komunitas

Dr. Ns. Mamnuah, M.Kep. Sp.Kep.J.

Dwi Ernawati, S.ST., M.Keb.

Dr. Yuli Isnaeni, SKp., M.Kep., Sp.Kom.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Instrumen *Recovery* Pasien Skizofrenia di Komunitas

Penulis: Dr. Ns. Mamnuah, M.Kep. Sp.Kep.J.

Dwi Ernawati, S.ST., M. Keb.

Dr. Yuli Isnaeni, SKp., M.Kep. Sp.Kom.

Desain Sampul : Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak : Achmad Faisal

ISBN: 978-634-7139-57-3

Cetakan Pertama: Maret, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram: @bimbel.optimal



PENERBIT:

Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

JUDUL DAN PENANGGUNG JAWAB	Instrumen recovery pasien skizofrenia di komunitas / Dr. Ns. Mamnuah, M.Kep., Sp.Kep.J., Dwi Ernawati, S.S.T., M.Keb., Dr. Yuli Isnaeni, S.Kp., M.Kep., Sp.Kom.
EDISI	Cetakan pertama, Maret 2025
PUBLIKASI	Jakarta Barat : PT Nuansa Fajar Cemerlang, 2025
DESKRIPSI FISIK	iv, 67 halaman ; 30 cm
IDENTIFIKASI	ISBN 978-634-7139-57-3
SUBJEK	Skizofrenia
KLASIFIKASI	616.898 [23]
PERPUSNAS ID	https://isbn.perpusnas.go.id/bo-penerbit/penerbit/isbn/data/view-kdt/1182463

Prakata

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan kasih dan sayangannya sehingga kami dapat menyelesaikan buku ini. Sholawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Buku berjudul Instrumen Recovery Pasien Skizofrenia di Komunitas merupakan buku yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat *recovery* pasien skizofrenia di komunitas. Buku ini berisi konsep tentang skizofrenia, konsep *recovery*, dan instrument *recovery*.

Kami berharap buku ini dapat memberikan manfaat bagi pasien, keluarga, masyarakat, tokoh masyarakat, tenaga kesehatan, tenaga profesional, dan semua pihak yang mendukung proses *recovery* pasien skizofrenia. Kami juga mohon masukan demi kesempurnaan buku ini di masa yang akan datang.

Desember, 2024

Penulis

Daftar Isi

Prakata.....	iii
Daftar Isi.....	iv

Bab 1 Pendahuluan	1
--------------------------------	----------

Bab 2 Skizofrenia.....	6
-------------------------------	----------

A. Pengertian Skizofrenia	6
---------------------------------	---

B. Tanda Gejala Skizofrenia.....	8
----------------------------------	---

C. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Skizofrenia	13
---	----

D. Penatalaksanaan Pasien Skizofrenia	28
---	----

Bab 3 <i>Recovery</i> pada Pasien Skizofrenia	36
--	-----------

A. Pengertian <i>Recovery</i>	36
-------------------------------------	----

B. Kriteria <i>Recovery</i>	37
-----------------------------------	----

C. Faktor yang Mempengaruhi <i>Recovery</i> Pasien Skizofrenia	38
---	----

D. Dampak <i>Recovery</i>	47
---------------------------------	----

Bab 4 Instrumen <i>Recovery</i>	49
--	-----------

A. Pengertian Instrumen.....	49
------------------------------	----

B. Kisi-Kisi Instrumen	50
------------------------------	----

C. Pengukuran Instrumen	51
-------------------------------	----

D. Cara Penggunaan Instrumen.....	53
-----------------------------------	----

Bab 5 Penutup	55
----------------------------	-----------

Daftar Pustaka	57
-----------------------------	-----------

Glosarium	63
------------------------	-----------

Profil Penulis.....	64
----------------------------	-----------

Bab 1

Pendahuluan

Sehat jiwa adalah suatu kondisi sejahtera yang dikaitkan dengan kebahagiaan, kesenangan, kepuasan, pencapaian, optimis atau harapan (Stuart, 2013). Kesehatan jiwa digambarkan dalam sebuah rentang respons dari adaptif sampai dengan maladaptif (Stuart and Laraia, 2005). Kesehatan jiwa sangat diperlukan dalam menjalani kehidupan. Apabila tidak bisa mencapai kesehatan jiwa, maka akan terjadi masalah psikososial, bahkan mungkin terjadi gangguan jiwa. Gangguan jiwa adalah pola perilaku atau psikologis yang ditunjukkan oleh individu yang menyebabkan distress, gangguan fungsi dan menurunkan kualitas hidup seseorang (Stuart, 2013).

Angka gangguan jiwa di dunia hampir mencapai 450 juta orang dan sepertiganya tinggal di negara berkembang. Sebanyak delapan dari sepuluh pasien gangguan jiwa tidak mendapatkan perawatan.

Tidak dijelaskan asal negara berkembang pasien yang tidak mendapatkan perawatan (Kompas.com., 2012). Begitupun angka gangguan jiwa di Indonesia. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007, angka gangguan jiwa di Indonesia adalah 0,46% dan angka gangguan jiwa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 0,4-0,5%.

Hasil Riskesdas berikutnya pada tahun 2013, menunjukkan angka gangguan jiwa berat di Indonesia adalah 1,7 per mil, artinya di antara 1000 orang terdapat satu sampai dua orang yang mengalami gangguan jiwa berat, termasuk skizofrenia. Jumlah tersebut sebagian besar belum mendapat pengobatan yang tepat, sehingga mengakibatkan kondisi orang dengan skizofrenia (ODS) masih sulit diterima kembali di masyarakat. Angka gangguan jiwa berat di Yogyakarta, yaitu 2,7 per mil melebihi angka nasional, yaitu 1,7 per mil. Skizofrenia merupakan salah satu jenis gangguan jiwa berat, yang diduga penyebabnya multifaktor, yaitu berbagai faktor yang secara bersama-sama berkontribusi mencetuskan terjadinya gangguan ini (Saptawati, 2014).

Berdasarkan surat edaran dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan tahun 2019, tentang data prevalensi skizofrenia bahwa hasil Riskesdas tahun 2013, angka gangguan jiwa berat di Indonesia adalah 1,5 per

1000, sedangkan Risesdas 2018, angka gangguan jiwa berat di Indonesia mengalami peningkatan menjadi 1,8 per 1000. Khusus di Yogyakarta, angka gangguan jiwa berat lebih besar dari angka nasional, yaitu pada tahun 2013 sebanyak 2,7 per 1000 dan pada tahun 2018 sebanyak 3,5 per 1000 (Kemenkes RI, 2019).

Angka prevalensi skizofrenia adalah sekitar 1% dari semua penduduk dunia, dari semua penderita skizofrenia tersebut, terdapat 15% anak yang salah satu orangtuanya penderita skizofrenia dan 35% anak yang kedua orangtuanya menderita skizofrenia (Videbeck, 2008). Pasien gangguan jiwa berat ini pada satu waktu memerlukan perawatan di rumah sakit. Menurut Murray *et al.* (2012), gangguan jiwa dan perilaku menunjukkan angka *disability-adjusted life years* (DALYs) pada tahun 1990 sebesar 5,7% dan meningkat pada tahun 2010 menjadi 7,4%. Skizofrenia merupakan salah satu dari lima penyebab utama beban penyakit, yaitu sebesar 0,6%.

Masalah kesehatan jiwa dapat memberikan kerugian ekonomi secara global hingga US\$16 triliun antara tahun 2010 hingga 2030 (CNN Indonesia, 2018). *Millennium Development Goals* (MDGs) telah berakhir pada tahun 2015 dan digantikan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs berisi tujuan pembangunan berkelanjutan hingga akhir 2030. Dalam SDGs disepakati 17 tujuan dengan 169 target dan 240 indikator terukur

yang di dalamnya terdapat pula indikator kesehatan jiwa yang sebelumnya tidak menjadi target MDGs (Sutopo *et al.*, 2014).

Recovery (pemulihan) merupakan aspek rehabilitasi, merujuk pada penggabungan atas keterbatasan sebagai bagian dari realitas, perubahan mimpi dan aspirasi, penggalian ide-ide baru dan sampai pada penyesuaian terhadap penyakitnya (Fontaine, 2009). Perjalanan setiap orang menuju *recovery* adalah unik. *Recovery* adalah proses yang panjang, pasien akan berubah dengan memperhatikan penempatan tujuan tempat dan cara hidup, bekerja, bersosialisasi, dan berekreasi. Proses *recovery* terputus antara pihak rumah sakit, keluarga dan layanan kesehatan terdekat pasien, yaitu puskesmas. Kegiatan rehabilitasi yang dilakukan di rumah sakit belum melibatkan keluarga dan puskesmas, sehingga keterampilan yang diperoleh selama di rumah sakit belum tentu bisa diterapkan dan mendapat dukungan di rumah. Ketika pasien merasa sudah sembuh, kemudian menunggu keluarga menjemput, sebenarnya pasien sudah masuk proses *recovery*.

Hasil penelitian sebelumnya mengatakan bahwa pasien yang melarikan diri dari rumah sakit sebenarnya sedang dalam proses *recovery*, karena ada tiga hal yang terjadi pada pasien tersebut, yaitu: adanya panggilan untuk pulang, antara harapan dan realitas dan yang

ketiga ada perbedaan persepsi antara kami (pasien) dan mereka (orang lain selain pasien) (Nurjannah *et al.*, 2009).

Persepsi tenaga professional tentang *recovery* pada pasien skizofrenia masih memiliki perbedaan. Tenaga professional yang mempunyai persepsi positif akan mengatakan kalau pasien skizofrenia mempunyai peluang untuk bisa pulih bahkan bisa tanpa minum obat, sedangkan petugas yang mempunyai persepsi negative mengatakan bahwa pasien skizofrenia tidak bisa pulih tapi disebut terkontrol dan tidak bisa lepas dari obat (Mamnuaah *et al.*, 2019). Penelitian *recovery* di Indonesia belum banyak dilakukan (Mamnuaah, *et al.*, 2016). Data tentang jumlah pasien skizofrenia yang mencapai *recovery* belum ada datanya. Pemerintah Indonesia belum memiliki instrument yang bisa digunakan untuk mengukur tingkat *recovery* pasien skizofrenia yang tetap. Instrumen ini telah disusun dan dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Hasilnya valid dan reliabel. Instrumen *recovery* ini dapat digunakan untuk mengukur tingkat *recovery* pasien skizofrenia di komunitas.

Bab 2

Skizofrenia

A. Pengertian Skizofrenia

Kata schizophrenia dikenalkan pada tahun 1908 oleh psikiater Swiss, yaitu Eugen Bleuler, berasal dari kata Yunani *skhizo* (split) artinya terbelah dan *phren* (mind) artinya pikiran. Pengertian skizofrenia diperoleh melalui perdebatan. Akhirnya disepakati dua hal, yaitu pertama bahwa skizofrenia bukan penyakit yang disebabkan oleh satu penyebab akan tetapi diakibatkan oleh berbagai penyebab, yaitu: predisposisi genetika, disfungsi biokimia, faktor fisiologis dan stres psikososial. Kedua, bahwa untuk menyembuhkan skizofrenia diperlukan tindakan yang menyeluruh dan dilakukan oleh berbagai disiplin ilmu (Townsend, 2014). Skizofrenia adalah salah satu bentuk kelainan neurobiologis dan menimbulkan respons yang dapat mengganggu kehidupan individu, keluarga dan masyarakat (Stuart, 2013).

Skizofrenia merupakan salah satu dari 10 penyebab utama disabilitas di seluruh dunia, bersifat kronis dan kambuh karena remisi tidak sempurna (Hariandja & Silaen, 2023). Skizofrenia adalah salah satu gejala gangguan kejiwaan cukup berat, dimana terjadi kerusakan otak persisten dan serius yang mengakibatkan perubahan perilaku psikotik, pemikiran konkrit dan kesulitan dalam memproses informasi, hubungan interpersonal dan memecahkan masalah (Stuart, 2013). Yosep dan Sutini (2015) mendefinisikan skizofrenia merupakan penyakit neurologis yang memengaruhi persepsi klien, cara berpikir, bahasa, emosi dan perilaku sosial.

Secara anatomi dan fisiologi, skizofrenia adalah gangguan perkembangan yang ditandai dengan perubahan neurobiologis yang mempengaruhi struktur dan fungsi otak. Gangguan ini melibatkan perubahan pada sirkuit frontotemporal dan frontosubkortikal pada tingkat neuron, yang berkontribusi pada gejala gangguan. Perubahan struktural dan fungsional ini menimbulkan kompleksitas skizofrenia sebagai kondisi yang muncul dari faktor genetik dan lingkungan, yang berdampak pada proses kognitif dan emosional pada individu yang terkena. Memahami dasar-dasar neurobiologis ini sangat penting untuk mengembangkan perawatan dan intervensi yang

efektif. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa skizofrenia adalah gangguan kejiwaan akibat gangguan perkembangan atau perubahan neurobiologis yang mempengaruhi struktur dan fungsi otak baik dari factor genetic maupun lingkungan, yang memengaruhi persepsi klien, cara berpikir, bahasa, emosi dan perilaku sosial.

Masalah keperawatan yang ditemukan pada pasien skizofrenia adalah: gangguan persepsi sensori halusinasi, gangguan proses pikir, isolasi sosial, risiko mencederai diri sendiri dan orang lain, hambatan komunikasi verbal, harga diri rendah, dan defisit perawatan diri (Towsend, 2014). Masalah keperawatan lain yang ditemukan pada pasien skizofrenia yaitu hambatan interaksi sosial dan risiko gangguan identitas pribadi (Stuart, 2013).

B. Tanda Gejala Skizofrenia

Skizofrenia adalah gangguan mental kronis yang kompleks yang memengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan, dan berperilaku. Gangguan ini sering kali melibatkan kehilangan kontak dengan realitas dan dapat menyebabkan kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Skizofrenia adalah gangguan mental kompleks yang ditandai dengan berbagai gejala yang mempengaruhi pikiran, perasaan, dan

perilaku seseorang. Ini biasanya bermanifestasi pada masa dewasa muda dan dapat menyebabkan kecacatan yang signifikan jika tidak dikelola secara efektif. Gejala skizofrenia umumnya dikategorikan menjadi gejala positif (nyata), negatif (samar) dan gejala kognitif, masing-masing berkontribusi pada dampak keseluruhan gangguan pada individu.

Skizofrenia ditandai dengan adanya gejala positif dan gejala negatif (Kneisl et al., 2004). Menurut DSM-IV, tanda dan gejala skizofrenia adalah adanya dua atau lebih gejala selama satu bulan dan menetap selama enam bulan. Gejala tersebut adalah: delusi, halusinasi, disorganisasi pembicaraan, disorganisasi nyata atau perilaku katatonik, dan gejala negatif (APA, 2000).

Gejala positif pada skizofrenia sering disebut sebagai gejala psikotik atau gejala gangguan jiwa berat (Hariandja & Silaen, 2023). Gejala positif ini meliputi delusi (waham), halusinasi dan perubahan persepsi, gangguan perilaku aneh, katatonia, gangguan pikiran bicara kacau, ekpraksia (meniru gerakan orang lain yang diamati), pikiran atau gagasan terpecah dan ambivalen. Moini et al. (2024) mengidentifikasi gejala positif pada pasien dengan skizofrenia sebagai berikut:

1. Halusinasi atau perubahan persepsi

Halusinasi adalah pengalaman sensorik tanpa ada rangsangan eksternal. Halusinasi yang paling sering dialami pasien dengan skizofrenia adalah halusinasi pendengaran, seperti mendengar suara meminta untuk lari keluar rumah, meminta untuk memukul seseorang, bisikan memaki-maki dan sebagainya (Moini et al., 2024).

2. Delusi atau waham

Delusi merupakan keyakinan palsu yang tidak masuk akal dan bertentangan dengan realitas, seperti sedang bertugas menjadi presiden, menjadi raja atau menjadi orang pintar yang bisa menyembuhkan penyakit, dan sebagainya (Moini et al., 2024).

3. Disorganisasi pikiran dan bicara

Pasien skizofrenia mengalami pola bicara yang tidak koheren, atau tidak logis, seperti bicara berbelit-belit tetapi tidak sampai pada tujuan pembicaraan (tangensialitas) dan pembicaraan tidak memiliki hubungan antara satu kalimat dengan kalimat lainnya, dan klien tidak menyadari atas apa yang dibicarakan (asosiasi longgar).

4. Perilaku aneh atau disorganisasi perilaku

Pasien dengan skizofrenia menunjukkan tindakan yang tidak pantas atau tindakan yang tidak dapat

diprediksi sebelumnya, seperti tiba-tiba kekanak-kanakan, mengamuk hebat tanpa bisa dikendalikan atau tiba-tiba bertindak konyol dan katatonia (Hariandja & Silaen, 2023).

Gejala negatif adalah gejala yang samar, dapat berupa afek datar, hilangnya motivasi dalam aktivitas, kurang perhatian terhadap diri, menarik diri atau apatis, anhedonia (tidak mampu merasakan kesenangan atau kenikmatan), asosial dan katatonia (imobilisasi karena faktor psikologis). Kirkpatrick (2006 dalam Mosolov & Yaltonskaya, 2022) menguraikan terdapat 5 gejala negatif yang sering dialami oleh skizofrenia, sebagai berikut:

1. Afek tumpul (*emotional flattening*)

Berkurangnya ekspresi emosi yang nampak pada ekspresi wajah, nada suara dan berkurangnya rasa tanggung jawab.

2. Alogia (*negative cognitive disorder*)

Pasien mengalami miskin bicara, menunjukkan kuantitas dan spontanitas bicara berkurang, atau berkurangnya kefasihan dalam berbicara, produktivitas pemikiran dan ucapan.

3. Avolisi (*apathy*)

Pasien mengalami penurunan motivasi, tujuan dan dorongan sosial untuk memulai dan melakukan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari.

4. Anhedonia

Pasien mengalami ketidakmampuan untuk menikmati kesenangan dari aktivitas yang menyenangkan, yang pada umumnya orang normal senang seperti mendapatkan hadiah atau penghargaan, dan sebagainya.

5. Asosialitas atau menarik diri

Pasien tampak tidak ada minat dalam berinteraksi sosial dengan lingkungan, sekalipun dengan lingkungan terdekat yakni keluarga.

Gejala kognitif muncul dalam bentuk deficit kognitif, pasien akan mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi (perhatian), mengingat (memori) dan fungsi eksekusi atau mengambil keputusan, yang berdampak pada fungsi hidup sehari-hari (Moini et al., 2024). Hariandja & Silaen (2023) menyebutkan gejala kognitif pada skizofrenia berupa deficit dalam memori (berkurangnya daya ingat), perhatian, penalaran dan pemecahan masalah, kecepatan pemrosesan, sosial kognitif, dan kecerdasan (IQ). Gangguan atau gejala positif, negatif dan kognitif secara bersama-sama berdampak pada pekerja atau fungsi interpersonal dan

perawatan diri (Ebert et al., 2019 dalam Hariandja & Silaen, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan tanda dan gejala skizofrenia dapat berupa halusinasi, delusi, bicara tidak terorganisir, perilaku aneh, afek tumpul, alogia, avolisi, anhedonisme, asosialitas dan deficit kognitif seperti mudah lupa, tidak bisa berkonsentrasi dan tidak bisa mengambil keputusan. Memahami tanda dan gejala ini sangat penting karena dapat menentukan ketepatan intervensi keperawatan pada klien dan keluarganya.

C. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Skizofrenia

Menurut Stuart (2013), proses terjadinya skizofrenia dijelaskan dalam rentang respon neurobiologis. Rentang respon neurobiologis ini terdiri dari respon adaptif sampai respon maladaptif. Kumpulan gejala skizofrenia dapat terlihat dari respon maladaptif. Skizofrenia adalah gangguan perkembangan saraf otak. Tidak ada satu hal yang menyebabkan skizofrenia, sehingga perlu dilakukan pengkajian hal-hal di bawah ini:

1. Faktor predisposisi

Faktor predisposisi terdiri dari biologis, psikologis, lingkungan dan sosial budaya. Secara neurobiologis, pasien skizofrenia menunjukkan adanya kelainan

anatomi, fungsional dan neurokimia dalam kehidupan otak post mortem. Hasil penelitian terhadap neurobiologi pada pasien menunjukkan bahwa pada pasien skizofrenia terjadi penurunan volume otak dan perubahan sistem neurotransmitter (Stuart and Laraia, 2005). Adanya gangguan pada korteks frontal mengakibatkan munculnya gejala negatif skizofrenia, sedangkan gangguan pada sistem limbik (dalam lobus temporal) akan memunculkan gejala positif (Stuart, 2013). Lingkungan intrauterin dan peristiwa dini pada bayi dapat berhubungan dengan perkembangan skizofrenia. Komplikasi prenatal dan perinatal pada orang dengan skizofrenia seperti preeklamsia, trauma, kekurangan oksigen pada saat melahirkan, prematuritas yang ekstrim, dan masalah ibu seperti gizi buruk, stres, penggunaan narkoba (tembakau, alkohol, kafein), infeksi virus, hipertensi, depresi dan penggunaan obat teratogenik, dapat meningkatkan efek lebih kuat untuk terjadinya skizofrenia. Paparan infeksi prenatal atau hipoksia meningkatkan risiko satu dari 100 menjadi dua dan empat di antara 100. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanita dengan tingkat antibodi toksoplasma memiliki risiko lebih tinggi mengembangkan gangguan skizofrenia (Stuart, 2013).

2. Faktor presipitasi

Menurut Stuart (2013), stresor presipitasi terjadinya skizofrenia ada dua, yaitu biologis dan gejala pemicu. Salah satu stresor biologis yang mungkin adalah adanya gangguan dalam umpan balik otak yang mengatur jumlah informasi yang dapat diproses pada waktu tertentu. Ketidakmampuan menyeleksi stimulus suara di pintu gerbang (gate) menyebabkan orang dengan skizofrenia menjadi takut keramaian atau menghadapi kebisingan. Gejala pemicu adalah stres tertentu yang mendahului terjadinya gangguan. Terdapat tiga gejala pemicu, yaitu: kesehatan, lingkungan dan sikap/perilaku. Berikut ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai gejala pemicu ini menurut Stuart (2013):

- a. Gejala pemicu kesehatan meliputi: gizi buruk, kurang tidur, ketidakseimbangan ritme sirkadian, kelelahan, infeksi, obat sistem saraf pusat, kurang olahraga, dan kesulitan mengakses pelayanan kesehatan.
- b. Gejala pemicu terkait dengan lingkungan yang meliputi: kesulitan perumahan, tekanan untuk bisa hidup mandiri, perubahan aktivitas, kesulitan hubungan interpersonal, isolasi sosial, kurangnya dukungan sosial, tekanan pekerjaan, stigmatisasi,

kemiskinan, kesulitan transportasi, dan kesulitan untuk mempertahankan pekerjaan.

- c. Gejala pemicu terkait dengan sikap/perilaku: konsep diri yang rendah (merasa miskin), putus asa (kurang percaya diri), kegagalan, kurang kontrol, merasa dikuasai gejala, perilaku yang berbeda dengan orang lain, keterampilan sosial yang buruk, perilaku agresif, perilaku kekerasan, manajemen obat yang buruk dan manajemen gejala yang buruk.

3. Penilaian terhadap stressor

Model diatesis stres menyatakan bahwa gejala skizofrenia berkembang berdasarkan pada hubungan antara stres yang dialami oleh seseorang dan kemampuan seseorang menghadapi stresor (Stuart, 2013).

4. Sumber coping

Menurut Stuart (2013), keluarga membutuhkan penyesuaian ketika memiliki anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa. Hal-hal yang mempengaruhi proses penyesuaian adalah sumber daya keluarga seperti pemahaman orangtua tentang penyakit, ketersediaan keuangan, ketersediaan waktu dan tenaga, dan kemampuan memberikan dukungan secara terus menerus. Sumber coping yang perlu dikaji pada pasien skizofrenia adalah:

kemampuan personal, dukungan sosial, modal material termasuk pembiayaan, dan keyakinan positif yang dimiliki oleh pasien.

5. Mekanisme koping

Menurut Stuart (2013), terdapat tiga jenis mekanisme koping, yaitu: pertama, mekanisme koping berfokus pada masalah (upaya langsung untuk mengatasi masalah) misalnya: negosiasi, konfrontasi, dan mencari saran. Kedua, mekanisme koping berfokus secara kognitif (mengendalikan masalah lalu menetralsirkannya) misalnya: membandingkan hal positif, ketidaktahuan memilih, mengganti reward, dan mengevaluasi kembali objek yang diinginkan. Ketiga, mekanisme koping berfokus pada emosi (diorientasi untuk mengurangi distress emosionalnya) misalnya: denial, supresi, dan proyeksi.

Skizofrenia dipengaruhi interaksi yang kompleks dari beberapa factor, yakni factor genetic, lingkungan dan psikososial serta factor perkembangan syaraf dan neurokimia (Kusman, 2024). Lohrs dan Hasan (2019) menyebutkan bahwa kecenderungan genetic, komplikasi perinatal, trauma masa kanak-kanak, penyalahgunaan ganja selama masa remaja, stress selama kehamilan dan kekurangan gizi. Yosep dan

Sutini (2015) menyebutkan faktor yang mempengaruhi terjadinya skizofrenia antara lain perubahan struktur fisik otak, perubahan struktur kimia otak dan faktor genetik. Berdasarkan uraian di atas terdapat kombinasi atau interaksi beberapa faktor yang saling berkaitan, sehingga pembahasan faktor penyebab ini tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Dari berbagai faktor penyebab skizofrenia, dapat dikategorikan menjadi faktor biologi (termasuk keturunan dan genetik), psikososial dan lingkungan atau dikategorikan sebagai internal dan faktor eksternal (Sunaryo dan Ronald, 2018), yang akan diuraikan sebagai berikut.

1. Faktor Biologi

Faktor biologi merupakan faktor internal yang berasal dari dalam diri seseorang, yang melibatkan genetik dan keturunan serta perkembangan syaraf dan neurokimia (Sunaryo dan Ronald, 2018).

a. Faktor keturunan

Skizofrenia terkenal dengan kelainan atau penyakit yang diturunkan atau diwariskan. Sebuah studi menyebutkan bahwa risiko skizofrenia meningkat seiring dengan semakin dekatnya derajat kekerabatan seseorang dengan pasangan hidup dan menurun seiring dengan semakin jauhnya derajat kekerabatan (Kusman, 2024). Faktor genetik dapat menentukan struktur

dan fungsi otak, yang akan memengaruhi psikologi dan pola perkembangan otak. Faktor keturunan memiliki peran penting terjadinya dan berkembangnya penyakit skizofrenia. Hasil survey Tsuang menunjukkan bahwa heritabilitas skizofrenia sebesar 68,8%, sedangkan menurut pendapat Li Pu (dalam Gao, Ma & Yuan, 2024) sebesar 80%.

b. Faktor genetik

Faktor genetik berbeda dengan faktor keturunan, faktor genetic gen dan DNA seseorang, termasuk perubahan atau mutasi genetic yang muncul secara spontan selama perkembangan individu. Penelitian genetika telah mengidentifikasi banyak varian genetika yang berkaitan dengan skizofrenia, namun tidak ada satu gen yang menyebabkan skizofrenia secara langsung melainkan kombinasi dari banyak varian. Beberapa gen yang memengaruhi fungsi otak adalah dopamine dan glutamate. Kedua neurotransmitter ini sering terganggu pada skizofrenia. Faktor genetik dapat menentukan struktur dan fungsi otak, yang akan memengaruhi psikologi dan pola perkembangan otak. Meskipun genetik meningkatkan kerentanan,

namun factor lingkungan sering menjadi factor pemicu munculnya skizofrenia.

c. Faktor perkembangan syaraf dan neurokimia

Perubahan struktur otak terjadi akibat perkembangan, pengalaman, trauma dan gangguan neurologis. Perubahan struktur otak dapat berupa perubahan bentuk, ukuran, dan perubahan bagian spesifik seperti perubahan di korteks prefrontal, hippocampus atau amigdala. Perubahan struktur kimia, disebabkan oleh tekanan stres, kecanduan atau penyakit mental. Struktur kimia yang berubah adalah neurotransmitter (dopamin, serotonin atau glutamat) dan hormon yang memengaruhi fungsi otak.

Skizofrenia sering dikaitkan dengan gangguan perkembangan otak, misalnya gangguan migrasi neuron, proses mielinisasi, atau sinaptogenesis (pembentukan sinapsis). Perubahan ini dapat menyebabkan konektivitas yang tidak normal di otak, terutama di area yang mengatur pemikiran, emosi, dan persepsi, seperti korteks prefrontal dan hippocampus. Proses pemangkasan sinapsis (*synaptic pruning*) terjadi

secara alami selama masa remaja. Pada individu dengan skizofrenia, pemangkasan ini dapat terjadi secara berlebihan, yang dapat mengganggu fungsi koneksi saraf dan menyebabkan gejala seperti delusi atau halusinasi.

Disfungsi dopamin: Hipotesis dopamin adalah salah satu teori utama dalam skizofrenia. Ketidakseimbangan dopamin, khususnya peningkatan aktivitas dopamin di jalur mesolimbik, dapat menyebabkan gejala psikotik (seperti delusi dan halusinasi). Sementara itu, penurunan aktivitas dopamin di jalur mesokortikal dapat berkontribusi pada gejala negatif (seperti apati atau penarikan sosial).

Penurunan fungsi reseptor glutamat tipe NMDA (N-Methyl-D-Aspartate) juga dianggap memainkan peran dalam skizofrenia. Gangguan sistem glutamat dapat memengaruhi koneksi saraf dan menimbulkan gangguan kognitif serta gejala psikotik. GABA (gamma-aminobutyric acid) adalah neurotransmitter penghambat utama di otak. Penurunan fungsi sistem GABA dapat menyebabkan overaktivitas otak, yang juga terkait dengan gejala skizofrenia.

2. Faktor psikososial

Gangguan kepribadian atau personalitas merupakan pemicu terjadinya skizofrenia. Gangguan kepribadian mengacu pada pola tetap psikologi dan perilaku individu abnormal yang menyimpang dari masyarakat dan menyebabkan masalah dan kesakitan pada diri sendiri atau orang lain. Misalnya penakut, introvert, sensitif dan curiga, suka berfantasi, negatif, menarik diri dan sebagainya. Pembentukan kepribadian berkaitan dengan faktor genetik tertentu dan pendidikan serta lingkungan tempat tinggal yang diperoleh, sehingga seseorang dengan masalah kepribadian akan menjadi baik atau memburuk menjadi gangguan jiwa, dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya.

3. Faktor lingkungan

Gao, Ma & Yuan (2024) menyebutkan bahwa terdapat dua penyebab utama terjadinya skizofrenia yakni penyebab psikososial dan factor lingkungan. Faktor lingkungan berkontribusi terhadap perkembangan skizofrenia, baik lingkungan biologi atau fisik maupun lingkungan sosial. Kejadian infeksi selama masa dalam kandungan, aktivasi system imun, gangguan gizi, ayah yang berusia lanjut, penggunaan narkoba pada usia dini dan imigrasi merupakan factor resiko skizofrenia. Gao, Ma &

Yuan (2024) membagi beberapa factor lingkungan yang menyebabkan skizofrenia sebagai berikut:

a. Faktor keluarga

Keluarga adalah unit masyarakat yang paling dasar dan landasan pertumbuhan pribadi. Status sosial atau pendapatan keluarga dan buruknya hubungan antar anggota keluarga merupakan faktor penyebab skizofrenia. Pendapatan keluarga dan status sosial menjadi penyebab terjadinya skizofrenia. Kondisi keluarga yang tidak memadai menyebabkan kurangnya jaminan asuhan keperawatan bagi ibu hamil selama kehamilan atau komplikasi ibu saat melahirkan, seperti hipoksia dan perawatan keluarga yang buruk, yang dapat menyebabkan kelainan otak pada bayi baru lahir, sehingga menyebabkan skizofrenia dan gangguan jiwa lainnya.

Di sebagian besar keluarga dengan orang tua tunggal, seringkali sulit untuk memastikan makanan dan gizi anak-anak karena tekanan keuangan. Pola makan yang buruk dalam jangka panjang, menyebabkan anak-anak mengalami kurang gizi. Sampai batas tertentu, kesehatan yang buruk juga dapat menimbulkan sikap negatif dan psikologi negatif pada anak, sehingga

kekurangan gizi dalam jangka panjang juga menjadi penyebab penyakit jiwa pada anak.

Perselisihan keluarga adalah penyebab skizofrenia. Orang tua tunggal, tidak dapat melampiaskan besarnya tekanan ekonomi dan pekerjaan yang ditanggung seseorang, mereka sering melampiaskan kemarahan pada anak-anak. Kritik dan devaluasi jangka panjang terhadap anak akan membuat anak mengembangkan harga diri yang rendah, pengecut, kurang percaya diri, dan penghindaran tanggung jawab, sikap dan kinerja. Sikap negatif jangka panjang akan membuat anak secara pasif menghindari dunia, dan autisme jangka panjang pada akhirnya akan berujung pada skizofrenia pada anak. Skizofrenia terutama disebabkan oleh kurangnya pengasuhan dalam keluarga dengan orang tua tunggal, dan sulitnya orang tua dari keluarga dengan orang tua tunggal untuk meluangkan waktu merawat anak-anaknya, yang merupakan salah satu alasan mengapa anak-anak menderita skizofrenia.

b. Trauma masa kanak-kanak

Trauma masa kanak-kanak mengacu pada kurangnya perhatian orang tua, pengabaian, atau pelecehan fisik dan emosional di masa kanak-

kanak. Trauma masa kanak-kanak lebih sering terjadi pada orang dengan penyakit mental dibandingkan pada orang normal. Penelitian menyebutkan bahwa 69% wanita dan 60% pria dengan penyakit mental pernah mengalami trauma masa kanak-kanak (She et al., 2013 dalam Gao, Ma dan Yuan, 2024).

Penelitian menunjukkan bahwa dalam situasi netral, pasien skizofrenia memiliki sikap permusuhan yang lebih jelas dibandingkan orang normal. Karena pasien pernah mengalami trauma di masa kanak-kanak, mereka secara tidak sadar akan menganggap lingkungan sebagai ancaman dan permusuhan, sehingga melancarkan serangan. Trauma masa kanak-kanak mempengaruhi perilaku agresif pasien melalui peran bias atribusi yang bermusuhan, yang dapat menyebabkan bias kognitif pasien (Chen et al., 2013 dalam Gao, Ma dan Yuan, 2024).

c. Faktor sosial budaya

Kemampuan sosial ekonomi, tekanan sosial, keyakinan agama, adat dan budaya, dapat menjadi faktor penyebab skizofrenia. Penelitian menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan fisik, dan konflik psikologis menjadi alasan utama masyarakat mempercayai

keyakinan agama. Karena beragama, sebagian penderita gangguan jiwa akan menolak pengobatan, sehingga penyakit jiwa tidak dapat diobati tepat waktu, dan selanjutnya berkembang menjadi skizofrenia berat. Karena penganut agama memiliki lebih banyak masalah dengan ketidakstabilan kepribadian dan konflik psikologis, hal ini berarti orang-orang tersebut lebih mungkin menderita penyakit mental.

- d. Faktor isolasi sosial atau rasa kesepian di masa kecil (*childhood loneliness*)

Beberapa pasien mengalami gangguan psikologis atau isolasi dari teman-temannya selama masa kanak-kanak, dan umumnya masalah ini juga dapat menyebabkan kurangnya rasa percaya diri dan sikap negatif pasien terhadap kehidupan. Menurut perilaku pasien, masalahnya adalah kurangnya objek untuk mengekspresikan emosi. Dalam kondisi stres yang kronis, tidak adanya orang yang bisa dihubungi dapat meningkatkan kemungkinan anak terkena skizofrenia, karena mereka biasanya menekan banyak hal. Kesepian yang berkepanjangan akan menimbulkan rasa ketergantungan, dan pasien berkeinginan untuk berkomunikasi dengan orang lain, namun karena

situasi kesepian pasien sendiri, tidak ada objek untuk berkomunikasi dengannya.

Orang-orang yang dalam kondisi kesepian jangka panjang di masa kanak-kanak cenderung mengalami lebih banyak penghindaran sosial di masa dewasa. Orang yang mengidap skizofrenia karena kesepian di masa kanak-kanak akan memiliki gejala yang sama dengan pasien yang mengalami pelecehan dengan kekerasan. Setelah interaksi dan adaptasi jangka panjang, pasien akan semakin bergantung pada efek skizofrenia. Reaksi negatif yang juga membuat pengobatannya lebih sulit.

e. Kehilangan

Penyebab lain dari skizofrenia adalah hilangnya sesuatu yang penting, biasanya orang tua, saudara atau teman yang penting bagi penderita. Setelah kehilangan orang penting, pasien akan menunjukkan kecenderungan autisme dan panik yang besar. Penderita sangat takut kehilangan lebih banyak orang, dan sebagian besar memilih untuk menipu diri sendiri atau terjerumus dalam kesedihan yang berkepanjangan, sehingga dalam keluarga yang kehilangan ayah atau ibu, kemungkinan besar anak akan terkena penyakit jiwa, hal ini juga

termasuk dalam pertanyaan untuk orang tua tunggal. Kemungkinan kehilangan kerabat dan teman yang menyebabkan penyakit mental sangat bergantung pada kapasitas psikologis pasien. Tidak ada keraguan bahwa kemungkinan skizofrenia yang disebabkan oleh kehilangan kerabat dan teman di masa kanak-kanak jauh lebih tinggi dibandingkan pada orang dewasa, dan skizofrenia jenis ini lebih sulit disembuhkan daripada yang disebabkan di masa dewasa karena paparan kepribadian pasien.

D. Penatalaksanaan Pasien Skizofrenia

Penatalaksanaan pada pasien skizofrenia bertujuan untuk mengontrol gejala, mencegah kekambuhan, dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Pendekatan ini bersifat holistik, melibatkan farmakoterapi, psikoterapi, dukungan sosial, serta manajemen psikososial.

1. Intervensi farmakoterapi

Menurut Hariandja dan Silaen (2023) menyebutkan bahwa hampir setiap pasien dengan skizofrenia mendapatkan manfaat dari terapi farmakologi, dan antipsikotik sebagai terapi farmakologis utama. Obat antipsikotik ini bekerja dengan cara menghambat pengikatan dopamine

di reseptor D2 pada empat jalur dopamine yaitu mesolimbic, mesokortikal, nigrostriatal dan tuberoinfundibular. Obat antipsikotik sering disebut sebagai major tranquilizer karena obat ini memiliki efek samping sedasi berat atau neuroleptika (muncul tanda neurologis) (Kaar et al., 2020 dan Stahl et al., 2021 dalam Hariandja dan Silaen, 2023).

Beberapa jenis obat-obatan psikotik yang digunakan untuk mengendalikan gejala positif, negatif dan kognitif, dan yang sering diresepkan oleh dokter antara lain clozapine (Hariandja & Silaen, 2023), risperidone, haloperidol, dan quetiapine (Arozal et al., 2019).

2. Psikoterapi (Terapi Perilaku Kognitif)

Jenis terapi perilaku kognitif atau CBT merupakan terapi nonfarmakologis yang paling umum diberikan, diikuti dengan Desensitisasi dan Pemrosesan Ulang Gerakan Mata (EMDR) dan Penyembuhan dan Terapi Spiritual. Menurut Yunitri, et al. (2023) psikoterapi terbukti secara signifikan mengurangi gejala Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) dengan durasi waktu dan frekuensi yang berbeda.

Beberapa manfaat terapi perilaku kognitif antara lain:

- a. membantu memahami realitas
- b. mengelola pikiran negatif
- c. mengurangi stress akibat halusinasi dan delusi
- d. meningkatkan kemampuan pemecahan masalah
- e. membangun strategi koping yang sehat
- f. mengurangi kekambuhan

3. Terapi Psiko-Religius

Terapi dikir merupakan terapi modalitas pada gangguan jiwa, dan telah terbukti efektif dalam mengelola halusinasi pendengaran, membantu pasien membedakan antara realitas dan khayalan (imajinasi) (Rosyada & Pratiwi, 2022). Kaplan et al menyatakan bahwa hanya 10% klien mendapatkan hasil optimal dalam menjalani terapi antipsikotik saat di rumah sakit, selebihnya klien akan pulang ke rumah yang membutuhkan terapi komprehensif. Kombinasi antipsikotik dan terapi religious, terbukti telah memberikan hasil lebih optimal pada klien halusinasi.

Terapi psikoreligius zikir merupakan metode untuk mencapai keseimbangan, berdzikir menyebabkan suasana tenang, respon emosi yang positif dan system endokrin menjadi lebih baik.

Pemusatan perhatian selama berdzikir membuat klien focus pada bacaan dzikir dan memusatkan perhatian dengan baik atau khusu', sehingga tidak lagi mendengar suara yang tidak nyata (Hidayatii, Rochmawati dan Targunawam, 2014 dalam Rosyada & Pratiwi, 2022)

4. Psikoedukasi pada keluarga (Family Psychoeducation/ FPE)

Keluarga memiliki kontribusi penting dalam proses penyembuhan dan penjaga kekambuhan pada skizofrenia (Isnaeni dan Nuraini, 2022). Dukungan keluarga yang baik, masa kesembuhan klien akan bertahan lama atau bahkan tidak mengalami kekambuhan sedikitpun, namun sebaliknya keluarga yang kurang mendukung maka frekuensi kekambuhan akan meningkat dan menjadi lebih cepat (Sari, 2014).

Psikedukasi keluarga atau family psychoeducation therapy merupakan salah satu program perawatan jiwa keluarga melalui pelaksanaan komunikasi terapeutik (Sari, 2024). Psikoedukasi ini memiliki program untuk meningkatkan pengetahuan keluarga tentang penyakit meliputi pengertian, penyebab, tanda dan gejala, gejala-gejala penyimpangan perilaku,

penatalaksanaan pengobatan dan perawatan selama di rumah, dan yang terpenting adalah peningkatan dukungan keluarga bagi seluruh anggota keluarga.

Baylon dan Maglaya (dalam Wahyuni, 2019) menyebutkan bahwa keluarga memiliki 5 tugas kesehatan terhadap semua anggota yakni mengenal masalah kesehatan atau penyakit yang dialami anggota keluarga, mengambil keputusan tindakan yang tepat, memberikan perawatan sehari-hari dengan memberikan dukungan psikososial pada klien, menciptakan suasana keluarga yang mendukung dan mencegah kekambuhan klien skizofrenia dan memanfaatkan layanan dan fasilitas kesehatan bagi klien.

5. Rehabilitasi Psikososial

Pelaksanaan rehabilitasi psikososial bagi klien dengan gangguan jiwa skizofrenia terbagi dalam dua tahap, yakni:

- a. Tahap 1 latihan non vokasional, terdiri dari psikoedukasi, manajemen kasus, latihan keterampilan sosial, latihan ketrampilan hidup, remediasi kognitif, spiritual, olah raga, seni dan komunitas terapeutik.

- b. Tahap 2 latihan vokasional, kegiatan langsung yang mengasah ketrampilan, seperti menjahit, menyulam, membuat sapu/kemoceng/keset, pertanian di sawah.
6. New somatic cell therapy atau pengobatan sel somatis baru

Memanfaatkan stimulasi magnetik transkranial berulang atau repeated transcranial magnetic stimulation, yang sering dikenal sebagai pengobatan RTM, kini dianggap sebagai salah satu metode yang paling bermanfaat untuk mengobati psikosis dan gejala terkait (Gao, Ma dan Yuan, 2024). Namun, pengobatan dari protokol yang tersedia saat ini masih sangat terbatas pada penelitian terkontrol dan acak. Selain itu, hasil pengobatan bervariasi di berbagai dimensi gejala, dengan beberapa manfaat pengobatan yang kuat untuk simulasi deteksi emosi.

Pengobatan RTM memiliki harapan untuk menjadi pilihan pengobatan, ke depan akan tersedia lebih luas dan jika pasien yang cenderung merespons stimulasi magnetik transkranial berulang (RTMS) dipilih secara cermat menggunakan profil klinis atau biomarker, dan rejimen pengobatan dioptimalkan. Misalnya,

analisis terbaru mengungkapkan bahwa lokasi stimulasi dan jenis stimulasi merupakan faktor penting dalam menentukan apakah stimulasi magnetik transkraniai berulang (RTMS) efektif dalam mengurangi keparahan halusinasi.

Menurut Townsend (2014), skizofrenia disebabkan oleh berbagai faktor, sehingga dalam penatalaksanaannya juga tidak bisa diatasi dengan satu cara saja. Tindakannya harus komprehensif, multidisiplin, termasuk pengobatan dan berbagai bentuk perawatan psikososial seperti keterampilan hidup dan social skills training (SST), rehabilitasi dan terapi keluarga.

Menurut Stuart (2013), tindakan yang dapat dilakukan pada pasien gangguan jiwa termasuk skizofrenia adalah: psikofarmakologi, tindakan perubahan perilaku dan kognitif, pencegahan dan pengelolaan perilaku agresif, terapi somatik, terapi komplementer dan alternatif, kelompok terapeutik dan tindakan pada keluarga. Sejumlah intervensi psikososial dapat diberikan kepada pasien skizofrenia, seperti latihan keterampilan sosial atau social skill training (SST), terapi perilaku kognitif atau cognitive behavior therapy (CBT), remediasi kognitif dan pelatihan kognisi sosial. Tindakan ini untuk memulihkan fungsi pasien, yaitu: stabilisasi

gejala, hidup mandiri, fungsi kerja dan fungsi sosial. Edukasi tentang skizofrenia sebaiknya diberikan kepada pasien dan anggota keluarga (Frisch and Frisch, 2006).

Penelitian lain juga menunjukkan adanya interaksi antara pengobatan dengan tindakan psikososial. Tindakan-tindakan psikososial ini membantu pasien skizofrenia berfungsi lebih baik dan tidak hanya untuk dapat mencapai stabilisasi dari gejala-gejala dari penyakit ini (Kern et al., 2009).

Bab 3

Recovery pada Pasien Skizofrenia

A. Pengertian *Recovery*

Recovery adalah kondisi normal sebelum pasien mengalami gangguan jiwa. Dengan kata lain, para praktisi kesehatan ini percaya bahwa pemulihan berarti penyakit menghilang, gejala berkurang, pasien tidak perlu lagi minum obat, fase setelah enam bulan remisi, pasien menjadi mandiri, dapat melakukan suatu kegiatan, berinteraksi, dan berkomunikasi secara efektif (Mamnuah et al., 2019). Menurut Stuart (2013), *recovery* didefinisikan sebagai proses ketika seseorang mampu hidup, bekerja, belajar dan berpartisipasi secara penuh di masyarakat. Newell and Gournay (2009) menjelaskan bahwa *recovery* tidak sekedar menurunnya gejala gangguan jiwa akan tetapi merupakan gabungan kemampuan dari aspek psikologis, sosial, pekerjaan, keluarga dan aspek lainnya.

Definisi *recovery* menurut Buckland, Schepp *et al.* (2013) mengandung empat hal, yaitu: pemenuhan dan pertahanan harapan, pembangunan identitas yang positif, penemuan arti hidup dan pengambilan tanggung jawab terhadap kehidupan orang lain. Melihat beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian *recovery* adalah proses yang dialami pasien untuk mencapai harapan disertai tanggung jawab untuk bisa hidup bermasyarakat.

Recovery adalah konsep yang multidimensional, tidak hanya berkurangnya gejala tetapi memiliki fungsi psikososial yang memadai, dan kesejahteraan yang dirasakan. Meskipun pasien tidak bebas gejala, akan tetapi mudah dikelola, dan tidak mengganggu orang lain. Mereka tidak hanya mampu mempertahankan diri secara fisik, tetapi juga mempunyai ketahanan emosional (Meesters, 2014).

B. Kriteria *Recovery*

Kriteria *recovery* menurut Jaaskelainen, Juola *et al.* (2013) adalah tidak ada episode pengobatan selama dua tahun, skor GAF >61, fungsi klinis dan sosial dalam rentang normal selama dua tahun, hidup mandiri selama dua tahun, tidak dirawat inap di rumah sakit jiwa selama lima tahun, dan tidak minum obat atau dosis rendah obat psikotik. Systematic review yang

dilakukan oleh Jaaskelainen, Juola et al. (2013) mendapatkan hasil bahwa terdapat satu di antara tujuh pasien skizofrenia yang memiliki kriteria *recovery* tersebut.

Liberman et al. (2002) merumuskan kriteria *recovery*, yaitu selama dua tahun berturut-turut memiliki kriteria sebagai berikut: tidak ada gejala positif dan negatif yang signifikan secara klinis, bisa bekerja dan berfungsi secara sosial, hubungan dengan keluarga dan rekan harmonis, mengikuti pertemuan atau berinteraksi dengan orang lain minimal seminggu sekali, hidup mandiri, merasa puas dalam kehidupannya, harga diri dan identitas diri stabil, ikut serta dalam pemilu dan bisa membela dirinya.

C. Faktor yang Mempengaruhi *Recovery* Pasien Skizofrenia

Faktor-faktor yang mempengaruhi *recovery* pasien skizofrenia meliputi:

1. Individu

Faktor individu yang mempengaruhi *recovery* adalah: hope and optimism, self responsibility, insight and determination, empowerment, dan spiritual strength. Pasien yang mempunyai harapan dan rasa optimis yang realistis terhadap masa depan yang lebih baik, dan mempunyai perasaan yang positif

terhadap dirinya maka akan membantu mempercepat *recovery*. Adanya tanggung jawab terhadap diri sendiri dan insight akan mempengaruhi *recovery*. Pemberdayaan diperoleh dari kesuksesan mencapai satu tujuan, berpartisipasi dalam kegiatan, menemukan perasaan baru yang memuaskan dan bermakna bagi orang lain. Kekuatan spiritual berhubungan dengan kemampuan berjuang dan adanya harapan (Lieberman, 2008).

Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor personal meliputi atribut personal dan pengalaman subjektif. Contoh atribut dan pengalaman yang dikaitkan dengan individu menuju *recovery*, adalah harapan, stigmatisasi, pemberdayaan, penerimaan diri, insight, kesadaran, kolaborasi dengan profesional, rasa otonomi dan kontrol diri, dan partisipasi untuk menolong dirinya sendiri dan menjalani program. Pengalaman subjektif dan atribut tidak hanya memediasi proses menuju *recovery*, tetapi juga mempertahankan *recovery*. Misalnya, tindakan atau program *selfhelp* akan menimbulkan rasa berdaya yang berperan dalam memotivasi seseorang untuk mempertahankan pengobatan dan rehabilitasi sesuai dengan kriteria *recovery* yang telah dicapai, pemberdayaan dapat dialami melalui kemandirian, kerja dan bebas dari psikosis. Memiliki

harapan untuk masa depan akan memperbaiki kualitas hidup melalui antusiasme dan hubungan terapeutik. Harapan akan membantu memotivasi seseorang untuk berubah dan aktif berpartisipasi dalam layanan klinis atau selfhelp. Pengalaman subjektif pemberdayaan dan harapan yang terus tumbuh setelah *recovery* tercapai akan dapat memperkuat dan mencegah individu dari kekambuhan (Lieberman and Kopelowicz, 2005). Hasil penelitian Sarwono dan Subandi (2013) menjelaskan bahwa aspek kognisi, afeksi, dan konasi saling menunjang kualitas reintegrasi pasien kepada masyarakat.

Faktor yang mendukung *recovery* pasien skizofrenia adalah penyesuaian, koping dan penilaian kembali, tanggung jawab terhadap sakit, dukungan sosial, hubungan dekat dan rasa memiliki, sedangkan faktor yang menghambat *recovery* adalah interaksi dan isolasi sosial, hambatan internal, ketidakpastian dan keputusan (Soundy et al. 2015).

2. Keluarga

Ketahanan keluarga (*family resilience*) didefinisikan sebagai kemampuan keluarga untuk menangkal atau melindungi diri dari berbagai permasalahan atau ancaman kehidupan baik yang datang dari dalam keluarga itu sendiri maupun dari

luar keluarga seperti lingkungan, komunitas, masyarakat, maupun negara. Terdapat lima indikasi yang menggambarkan tingkat ketahanan suatu keluarga, yaitu: (1) adanya sikap saling melayani sebagai tanda kemuliaan; (2) adanya keakraban antara suami dan istri menuju kualitas perkawinan yang baik; (3) adanya orang tua yang mengajar dan melatih anak-anaknya dengan berbagai tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten, dan mengembangkan keterampilan; (4) adanya suami dan istri yang memimpin seluruh anggota keluarganya dengan penuh kasih sayang; dan (5) adanya anak-anak yang menaati dan menghormati orang tuanya. Dalam konteks yang lebih luas, ketahanan keluarga diidentikan dengan ketahanan sosial karena keluarga merupakan unit terkecil dalam sistem sosial (KPPPA & BPS, 2016).

Keluarga yang mempunyai anggota keluarga yang mengalami skizofrenia maka ketahanan keluarga mudah rapuh. Hasil penelitian Fitryasari et al. (2018) menjelaskan bahwa stigma dan beban perawatan yang dirasakan keluarga dengan adanya anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa skizofrenia akan menurunkan kualitas hidup keluarga, keberfungsian keluarga, dan memberikan dampak negatif bagi ketahanan keluarga. Kondisi tersebut

akan menyulitkan keluarga dalam memberi dukungan pada pasien skizofrenia agar bisa mencapai *recovery*. Untuk itu, perlu dikembangkan intervensi keperawatan yang berbasis pada keluarga untuk meningkatkan ketahanan keluarga, seperti penelitian yang dilakukan oleh Mubin et al. (2019) tentang terapi psikoedukasi pada keluarga yang efektif menurunkan beban keluarga yang memiliki anggota keluarga dengan skizofrenia paranoid.

Dukungan keluarga (*family support*) sangat membantu pasien skizofrenia dalam proses *recovery* (Liberman, 2008). Peran keluarga akan membantu pasien dalam mencegah kekambuhan pasien skizofrenia sehingga pasien bisa pulih. Menurut Soundy et al. (2015), adanya dukungan sosial, hubungan dekat dan rasa memiliki akan mendukung *recovery* pasien skizofrenia. Hasil penelitian Sarwono dan Subandi (2013) menggambarkan bahwa semakin tinggi kelas sosial seseorang, proses reintegrasi pasien psikosis ke masyarakat semakin rendah, karena adanya ajaran bibit bobot bebet yang menjadi kendala psikologis untuk kembali ke masyarakat.

Menurut Kaakinem et al. (2015), ada empat pendekatan dalam perawatan keluarga. Keempat pendekatan tersebut adalah: keluarga sebagai

konteks dalam pengembangan individu, keluarga sebagai klien, keluarga sebagai sistem, dan keluarga sebagai bagian dari masyarakat. Keluarga sebagai konteks, artinya bahwa perawatan diberikan kepada individu dan dibutuhkan keterlibatan peran serta keluarga dalam meningkatkan status kesehatan individu tersebut. Keluarga sebagai klien, artinya bahwa setiap anggota keluarga mendapatkan asuhan keperawatan tidak hanya yang sakit. Ketika ada anggota keluarga yang sakit maka akan berdampak pada anggota keluarga yang lain. Keluarga sebagai sistem, artinya bahwa ada interaksi antar anggota keluarga yang mengalami sakit sehingga diperlukan pengkajian keluarga secara menyeluruh, sedangkan keluarga sebagai komponen masyarakat, artinya bahwa keluarga sebagai unit dasar dari masyarakat yang berfungsi sebagai lembaga pendidikan, ekonomi, agama, dan kesehatan. Keluarga juga berinteraksi dengan lembaga lain untuk saling menerima dan memberi pelayanan dan komunikasi.

Dukungan keluarga sangat penting bagi pemulihan pasien gangguan jiwa. Hal-hal yang berkaitan dengan keluarga dan perlu dikaji oleh perawat untuk membantu proses pemulihan pasien, meliputi: struktur keluarga (meliputi tahap perkembangan, peran, tanggung jawab, norma dan

nilai), sikap keluarga terhadap anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa, iklim emosional keluarga (ketakutan, kemarahan, depresi, ansietas, ketenangan), dukungan sosial yang tersedia untuk keluarga (keluarga besar, teman, dukungan finansial, keterlibatan religi, hubungan dengan masyarakat), pengalaman keluarga dengan pelayanan kesehatan jiwa, dan pemahaman keluarga terkait dengan masalah klien dan rencana asuhan keperawatan (Stuart, 2013). Keluarga merupakan bagian yang terintegrasi dalam pelayanan kesehatan jiwa, petugas kesehatan sudah menyampaikan kepada keluarga tentang diagnosis dan tindakan terhadap pasien skizofrenia sejak awal datang (Outram et al., 2015).

3. Masyarakat

Dukungan sosial dari masyarakat (community support) sangat diperlukan bagi pasien skizofrenia. Stigma pada pasien gangguan jiwa akan membuat menderita pasien dan keluarganya (Liberman, 2008). Hasil penelitian Sarwono dan Subandi (2013) menggambarkan bahwa pasien psikosis fase awal masih mudah mendapatkan berbagai jenis dukungan masyarakat, baik berupa penghargaan, penerimaan, informasi, jaringan sosial maupun dukungan instrumental. Masyarakat yang hidup dalam tata ekonomi tradisional masih cukup toleran untuk

memberikan dukungan, gotong royong, tepa slira, dan saling membantu. Dukungan dari kelompok sebaya (peer support) juga sangat membantu proses recovery pasien (Liberman, 2008). Dukungan sosial dari kelompok akan membantu mengurangi kekerasan, perilaku merendahkan ataupun otoriter (Liberman, 2008).

Menurut Wood et al. (2014), pasien skizofrenia mendapat stigma dari masyarakat. Ada tiga sikap stigma yang diterima pasien skizofrenia, yaitu: pandangan negatif terhadap pasien, menyalahkan pasien, dan menganggap pasien skizofrenia sulit untuk pulih. Stigma tersebut akan menghambat proses recovery pasien skizofrenia.

4. Tenaga profesional

Prinsip-prinsip pelayanan dalam rehabilitasi pasien jiwa untuk mencapai tahap recovery ada 10 meliputi: komprehensif, kontinyu, koordinasi, kolaborasi, berorientasi pada konsumen, konsisten, kompeten, koneksi, kepedulian, dan kooperatif (Liberman, 2008). Pelayanan kesehatan jiwa komprehensif, hal ini penting karena karakteristik pasien gangguan jiwa mempunyai perbedaan keterbatasan secara personal, sosial dan okupasional.

Pasien membutuhkan interaksi dengan tenaga kesehatan profesional dalam jangka waktu yang lama

sehingga akses untuk mendapatkan pelayanan obat dan psikososial haruslah tepat. Pengobatan harus dikombinasikan dan dikoordinasikan dengan pelayanan psikososial. Pelayanan tersebut harus terintegrasi dan multidisiplin. Pelayanan juga harus berorientasi pada konsumen dan diberikan dengan kasih sayang dan kompetensi yang berbasis bukti. Kolaboratif dengan pasien akan membantu menjamin tujuan, rencana tindakan, dan evaluasi pelayanan yang berorientasi pada konsumen. Integrasi yang komprehensif, terkoordinasi, terus menerus, kolaboratif, dan rehabilitasi yang berorientasi pada konsumen membutuhkan komitmen yang kuat dari pengelola dan pengambil kebijakan untuk menyediakan sumber daya, dukungan administrasi dan pelayanan yang bisa dipercaya (Liberman, 2008).

Menurut Liberman (2008), faktor-faktor yang mempengaruhi proses recovery pasien gangguan jiwa untuk bisa kembali hidup normal di masyarakat disingkat menjadi REFRESH, dijelaskan sebagai berikut:

- a. Relationships, adanya hubungan dengan orang lain untuk berbagi pengalaman, perasaan dan impian.

- b. Empowerment, menghargai diri sendiri yang berasal dari partisipasi, kesuksesan dan prestasi yang diraihny
- c. Family, adanya hubungan baik, kasih sayang, dan kebijaksanaan yang diberikan oleh keluarga
- d. Recreation, pasien bisa menikmati kegiatan di masyarakat secara normal, artinya masyarakat bisa menerima keadaan pasien dan bisa bergabung dengan mereka tanpa ada beban
- e. Education, pasien belajar pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan agar bisa hidup mandiri
- f. Spiritual, pasien mempunyai kekuatan untuk memperjuangkan makna sakit bagi dirinya dan mempunyai keyakinan bahwa dia tidak sendirian
- g. Hope, pasien mempunyai tujuan dengan harapan yang positif untuk perbaikan dirinya

D. Dampak *Recovery*

Recovery pada pasien gangguan jiwa bertujuan untuk meningkatkan kemandirian pasien. Adapun cara yang digunakan dengan memaksimalkan kekuatan individu misalnya: mengembangkan kekuatan dan potensi, keterampilan hidup, mengelola penyakit dan mengakses dukungan lingkungan. Dampak *recovery*

ini akan meningkatkan kualitas hidup pasien skizofrenia (Stuart, 2013).

WHO (2003) melaporkan bahwa hari-hari produktif yang hilang atau disability-adjusted life years (DALYs) akibat gangguan jiwa sebanyak 13%. Adanya stigma dan diskriminasi juga menghambat pasien untuk mencari bantuan (WHO, 2003).

WHO (2016) melaporkan bahwa orang dengan skizofrenia (ODS) cenderung mengalami pelanggaran hak asasi manusia, seperti pemasungan, penelantaran dan terjadi diskriminasi dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan perumahan. Depkes (2014) menjelaskan bahwa stigmatisasi dan diskriminasi yang dialami oleh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), antara lain: dikeluarkan dari sekolah, diberhentikan dari pekerjaan, diceraikan oleh pasangan, ditelantarkan oleh keluarga, dipasung, dan dirampas harta bendanya.

Bab 4

Instrumen *Recovery*

A. Pengertian Instrumen

Pengertian instrumen adalah alat yang dipakai dalam sebuah kegiatan penelitian yang khususnya sebagai pengukuran dan pengumpulan data. Bisa berupa angket, seperangkat soal tes, lembar observasi dan lain sebagainya. Instrumen sebuah penelitian juga merupakan sarana harus dibuat guna menampung dan mengolah berbagai data yang dikumpulkan untuk penelitian. Selain untuk pengumpulan data, instrumen ini juga melibatkan bagaimana pengolahan data yang dilakukan sebagai salah satu tahapan penelitian. Hal ini sesuai dengan arti lain dari istilah ini, yakni sebagai sumber bagi seseorang yang akan melakukan penelitian. Instrumen yang ada pun bermacam-macam dan tergantung dari jenis penelitian yang digunakan. Jika penelitian yang dilakukan melibatkan survei, maka instrumen yang harus digunakan berupa angket yang isinya pertanyaan serta jawaban yang sesuai. Sementara itu jika menggunakan

observasi, maka yang dipakai adalah lembar observasi yang isinya sesuai dengan kebutuhan dalam pengamatan yang dilakukan oleh para peneliti. Kemudian apabila teknik yang digunakan adalah wawancara, maka harus menerapkan pedoman wawancara yakni sekumpulan pertanyaan yang digunakan dalam wawancara sebagai instrumen yang harus disiapkan. Dalam pengolahan data menggunakan lembar observasi, biasanya yang digunakan adalah *rating scale* atau skala penilaian.

B. Kisi-Kisi Instrumen

Kisi-kisi instrument *recovery* hasil uji validitas dan reliabilitas didapatkan hasil dari total 40 soal terdapat dua pertanyaan yang tidak valid yaitu soal nomor 6 dan nomor 10 tentang indikator fisik. Hasil uji validitas berada direntang 0,419-0,884. Hasil uji reliabilitas adalah 0,977. Kisi-kisi instrument *recovery* dapat dilihat pada Tabel 4.1

Tabel 4.1 Kisi-kisi instrumen *recovery* pasien skizofrenia

No	Indikator	No soal
1	Indikator Fisik	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
2	Indikator Psikologis	12,13,14,15,16
3	Indikator Sosial	17,18,19
4	Indikator Ekonomi	20,21,22

5	Indikator Religius	23,24
6	Indikator Pengobatan	25,26
7	Indikator Komunikasi	27,28,29,30,31
8	Observasi	1,2,3,4,5,6,7,8,9

C. Pengukuran Instrumen

Uji Validitas diartikan sebagai suatu konsep diukur secara akurat dalam penelitian kuantitatif. Ada tiga jenis bukti yang dapat digunakan untuk menunjukkan suatu instrumen penelitian memiliki validitas konstruk yaitu homogenitas, konvergensi dan bukti teori. Ukuran kualitas yang kedua dalam penelitian kuantitatif adalah reliabilitas, atau keakuratan suatu instrumen (Heale & Twycross, 2015). Artinya bahwa validitas suatu penelitian berkaitan dengan sejauh mana seorang peneliti mengukur apa yang seharusnya diukur. Secara khusus, validitas penelitian kuantitatif berakar pada pandangan empirisme yang menekankan pada bukti, objektivitas, kebenaran, deduksi, nalar, fakta dan data numeric (Golafshani, 2015).

Alat pengukuran yang umum dipakai ialah kuesioner dan tes. Dalam konteks ini, alat ukur kuesioner tersebut perlu disusun sedemikian rupa agar dapat dijadikan instrumen yang tepat untuk mendapatkan, menemukan, mendeskripsikan, mengeksplorasi, dan/atau membandingkan berbagai

informasi, topik, dan variabel penelitian. Berikut ini dijelaskan tentang jenis-jenis validitas instrumen penelitian kuantitatif (kuesioner atau tes) (Budiastuti & Bandur, 2018). Instrumen *recovery* ini telah dinilai memenuhi validitas konstruksi sehingga dilakukan uji validitas dan reliabilitas pada 30 responden, agar instrumen ini bisa dimanfaatkan di komunitas. Instrumen ini terdiri dari 40 item pertanyaan, setelah diuji validitas dan reliabilitas menjadi 38 item pertanyaan karena ada 2 pertanyaan yang tidak valid. Pertanyaan pada item instrumen *recovery* ini dikatakan tidak valid karena nilainya tidak memenuhi nilai rentang validitas pada instrumen yaitu 0,419-0,884. Item pertanyaan indikator fisik nomer 6 memiliki nilai 0,350 dan nomer 10 memiliki nilai 0,112. Hasil uji reliabilitas pada instrument ini adalah 0,977 yang berarti instrument penelitian ini reliabel dan bisa digunakan. Koefisien reliabilitas Alfa Cronbach diantara 0,70-0,90. Cronbach adalah tes yang paling umum digunakan untuk menentukan nilai reliabilitas kuesioner. Hasil Cronbach adalah angka antara 0 dan 1. Skor reliabilitas yang dapat diterima adalah $> 0,6$ (Heale & Twycross, 2015).

Instrumen *recovery* pada pasien skizofrenia di komunitas telah dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Ada 40 soal yang telah diuji validitas dan reliabilitas.

Dari 40 soal ada dua soal yang tidak valid, sehingga 38 soal dikatakan valid. Hasil uji reliabilitas dikatakan instrumen telah reliable. Instrumen yang tidak valid diperbaiki susunan kalimatnya agar tidak menimbulkan multi tafsir. Selanjutnya seluruh instrumen tersebut dapat digunakan sejumlah 40 soal. Instrumen *recovery* dapat diterapkan untuk mengukur tingkat *recovery* pasien skizofrenia di komunitas. Diharapkan instrumen ini dapat digunakan oleh tenaga kesehatan untuk mengukur tingkat *recovery* pasien gangguan jiwa di komunitas. Untuk peneliti berikutnya diharapkan dapat melanjutkan penelitian untuk meneliti efektifitas instrumen *recovery* ini.

D. Cara Penggunaan Instrumen

Cara penggunaan instrumen diisikan oleh tenaga kesehatan atau tenaga profesional terlatih dengan menanyakan kepada keluarga, *caregiver*, atau pasien skizofrenia. Instrumen ini terdiri dari dua bagian yaitu lembar kuesioner dan lembar observasi. Lembar kuesioner diisi dengan mencentang (✓) kategori yang telah disediakan. Terdapat empat kategori jawaban dengan klasifikasi berikut:

1. Selalu, jika indikator dilakukan setiap hari dalam seminggu. Kategori ini memiliki skor 4.

2. Sering, jika indikator dilakukan lebih dari atau sama dengan 4 hari dalam seminggu. Kategori ini memiliki skor 3.
3. Kadang-kadang, jika indikator dilakukan kurang dari atau sama dengan 3 hari dalam seminggu. Kategori ini memiliki skor 2.
4. Tidak pernah, jika indikator tidak dilakukan sama sekali. Kategori ini memiliki skor 1.

Lembar observasi cukup dicentang (✓) sesuai dengan kondisi di lapangan. Pada lembar observasi memiliki 2 kategori dengan klasifikasi berikut:

1. Ya, Jika indikator terlihat/ ditemui saat pengamatan. Kategori ini memiliki skor 2.
2. Tidak, Jika indikator tidak terlihat. Kategori ini memiliki skor 1

Kesimpulan akhir:

1. Jika skor total 108 - 142, pasien dapat dikatakan *Total recovered*.
2. Jika skor total 74 -107, pasien dapat dikatakan *Partially recovered*.
3. Jika skor total 40 -73, pasien dapat dikatakan *Unrecovered*.

Bab 5

Penutup

Skizofrenia merupakan salah satu jenis gangguan jiwa berat. Pasien skizofrenia juga bisa mencapai *recovery*. Tenaga profesional masih memiliki perbedaan persepsi tentang definisi *recovery*. Untuk itulah diperlukan instrument untuk mengukur tingkat *recovery* pasien skizofrenia terutama pasien-pasien yang ada di komunitas. Instrumen ini disusun untuk mengukur tingkat *recovery* pasien skizofrenia. Instrumen *recovery* ini terdiri dari 40 pertanyaan dan telah dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas pada 30 responden. Hasilnya dinyatakan valid dan reliabel. Dari sejumlah soal 40, terdapat dua soal yang tidak valid dan dilakukan perbaikan susunan kalimatnya agar tidak multi tafsir sehingga seluruh pertanyaan tersebut dapat digunakan untuk mengukur tingkat *recovery* pasien.

Instrumen *recovery* ini terdiri dari indikator fisik, psikologis, social, ekonomi, religius, pengobatan, dan komunikasi. Instrumen *recovery* ini dapat digunakan untuk mengukur tingkat *recovery* pasien skizofrenia di komunitas.

Daftar Pustaka

- APA 2000. *Diagnostic and statistical manual of mental disorders*, Washington DC, American Psychiatric Association.
- Arozal, W. Wijaya, D. dan Soettikno, V. (2019) Treatment patterns og antipsychotics and clinical features for treating with schizophrenia at the teaching hospital in Jakarta, Indonesia. *Journal of applied pharmaceutical science*.
- Buckland, H. T., Schepp, K. G. & Crusoe, K. 2013. Defining happiness for young adults with schizophrenia: a building block for recovery. *Archives of psychiatric nursing*, 27, 235-40.
- CNN Indonesia. 2018. *Krisis kesehatan jiwa kuras perekonomian global hingga 2030*. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20181010132410-255-337277/krisis-kesehatan-jiwa-kuras-perekonomian-global-hingga-2030>, diakses tanggal 26 Mei 2019
- Depkes. 2014. *Stop Stigma dan Diskriminasi terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)* [Online]. Available: <http://www.depkes.go.id/article/view/201410270011/stop-stigma-dan-diskriminasi-terhadap-orang-dengan-gangguan-jiwa-odgj.html> [Accessed 27 Agustus 2016].
- Fitryasari, R., Yusuf, A., Nursalam, Tristiana, R.D., & Nihayati, H.E. 2018. Family members' perspective of family Resilience's risk factors intaking care of schizophrenia patients. *International Journal of Nursing Sciences*, 5, 255-261.
- Fontaine, K. L. 2009. *Mental Health Nursing*, New Jersey, Pearson Prentice Hall.
- Frisch, N. C. & Frisch, L. E. 2006. *Psychiatric mental health nursing*, Canada, Thomsom Delmar Leraning.
- Gao, Q., Ma. Y., & Yuan, Z. (2020). The Causes of schizophrenia in adolescents. <https://www.brightpathbh.com>.

- Golafshani, N. (2015). Understanding Reliability and Validity in Qualitative Research. *The Qualitative Report*. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2003.1870>
- Hariandja, S.H. & Silaen, R.M. (2023). Penggunaan Clozapine pada Pasien Skizofrenia: Sebuah Tinjauan Pustaka. *Jurnal Hasil Penelitian dan Pengembangan*. Volume 1 No 3 Bulan Juli Tahun 2023 Hal 142-149.
- Heale, R., & Twycross, A. (2015). Validity and reliability in quantitative studies. *Evidence-Based Nursing*, 18(3), 66–67. <https://doi.org/10.1136/eb-2015-102129>
- Isnaeni, Y., dan Nuraini, H.M. (2020). Family emotional expression towards schizophrenia patients in Grhasia Mental Hospital Yogyakarta. *International Journal of Helath Science and Technology*, 1 (3), 2020
- Jaaskelainen, E., Juola, P., Hirvonen, N., Mcgrath, J. J., Saha, S., Isohanni, M., Veijola, J. & Miettunen, J. 2013. A systematic review and meta-analysis of recovery in schizophrenia. *Schizophrenia bulletin*, 39, 1296-306.
- Kaakinen, J. R., Coehlo, D. P., Steele, R., Tabacco, A. & Hanson, S. M. H. 2015. *Family health care nursing theory, practice and research*, Philadelphia, F. A. Davis Company.
- Kusman, A. (2024). Chapter Aetology and Risk Factors of Schizophrenia. *New Approaches to the Management and Diagnosis of Schizophrenia*. IntechOPen.
- Kemenkes RI. 2019. *Data prevalensi skizofrenia/psikosis*. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta.
- Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (KPPPA) dan Badan Pusat Statistik (BPS). 2016. *Pembangunan ketahanan keluarga 2016*.

- Kneisl, C. R., Wilson, H. S. & Trigoboff, E. 2004. *Contemporary psychiatric mental health nursing*, New Jersey, Pearson Education Inc.
- Kompas.Com. 2012. *WHO: 450 Juta Orang Menderita Gangguan Jiwa* [Online]. Available: <http://health.kompas.com/read/2012/10/10/17101692/WHO.450.Juta.Orang.Menderita.Gangguan.Jiwa> [Accessed 1 Desember 2015].
- Liberman, R.P. 2008. Recovery from disability manual of psychiatric rehabilitation. Washington DC. American Psychiatric Publishing Inc.
- Liberman, R. P. & Kopelowicz, A. 2005. Recovery from schizophrenia: A concept in search of research. *Psychiatric Services*, 56, 735-742.
- Liberman, R. P., Kopelowicz, A., Ventura, J. & Gutkind, D. 2002. Operational criteria and factors related to recovery from schizophrenia. *International Review of Psychiatry*, 14, 256-272.
- Löhrs, L. and Hasan, A. (2019). Risk factor for the development of schizophrenia. *Fortschr Neurol Psychiatr*. 2019 Feb; 87(2): 133-143.
- Mamnua. (2021). The Role of the Family in Preventing Relapse of Schizophrenia Patient. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 9, 44-49. <https://doi.org/10.1097/ADT.0000000000000277>
- Mamnua., Nurjannah, I., Prabandari, Y. S., Raymondalexa, C. M., Literature review of mental health recovery in Indonesia. *GSTF Journal of Nursing and Health Care (JNHG)* Vol.3 No.2, June 2016.
- Mamnua, A., Nurjannah, I., Suryo Prabandari, Y., & Marchira, C. R. (2019). Health Professional's Perceptions Toward Recovery of Patients with Schizophrenia in Community. *The Open Public*

- Meesters, P. D. 2014. Late-life schizophrenia: remission, recovery, resilience. *Am J Geriatr Psychiatry*, 22, 423-426.
- Moini, J. LoGalbo, A. and Ahangari, R.(2024). Chapter 18-Schizophrenic disorders. in *Foundations of the Mind, Brain, and Behavioral Relationship, Understanding Physiological Psychology*, 2014 page 305-317. Academic Press. doi <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-95975-9.00019-6>
- Mosolov, S.N. & Yaltonskaya, P.A. (2022). Primary and secondary negative symptoms in schizophrenia. *Frontiers in Psychiatry*. January 2022. Vol 12.
- Mubin, M. F., Riwanto, I., Soewadi, Sakti, H., & Erawati, E. 2019. Psychoeducational therapy with families of paranoid schizophrenia patients. *Enfermería Clínica*. <https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2018.12.006>
- Murray, C. J. L., Vos, T., Lozano, R., Naghavi, M., Flaxman, A. D., Michaud, C., Lopez, A. D. (2012). Disability-adjusted life years (DALYs) for 291 diseases and injuries in 21 regions , 1990 – 2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. *Lancet*, 380(Desember 15/22/29), 2197–223. [http://doi.org/10.1016/S0140-6736\(12\)61689-4](http://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)61689-4)
- Newell, R. & Gournay, K. 2009. *Mental health nursing an evidence-based approach*, Philadelphia, Churchill Livingstone Elsevier.
- Nurjannah, I., Fitzgerald, M. & Foster, K. 2009. Patients' experiences of absconding from a psychiatric setting in Indonesia. *International journal of mental health nursing*, 18, 326-335.
- Outram, S., Harris, G., Kelly, B., Bylund, C. L., Cohen, M., Landa, Y., Levin, T., Sandhu, H., Vamos, M. & Loughland, C. 2015. 'We didn't have a clue': Family caregivers' experiences of the communication of a diagnosis of schizophrenia. *The International journal of social psychiatry*, 61, 10-6.

- Rosyada, A. dan Pratiwi, Y.S. (2021). Penerapan Terapi Psioireligius Zikir pada Klien Gangguan Halusinasi Pendengaran. Prosiding Seminar Nasional Kesehatan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Tahun 2021
- Saptawati, R. 2014. *Prevalensi Gangguan Jiwa Berat Mencapai 1-2 orang dari 1.000 Warga di Indonesia* [Online]. Available: http://www.rri.co.id/post/berita/104224/nasional/prevalensi_gangguan_jiwa_berat_mencapai_12_orang_dari_1000_warga_di_indonesia.html [Accessed 30 Nopember 2015].
- Sari, H. (2014) Terapi psikoedukasi keluarga terhadap kemampuan keluarga dalam merawat klien dengan schizophrenia di rumah sakit jiwa pemerintah Aceh. INJEC Vol 1 No 2.
- Sarwono, R.B. & Subandi. 2013. Mereka memanggilku "kenthir". *Jurnal psikologi*, 40 (1), 1-14.
- Soundy, A., Stubbs, B., Roskell, C., Williams, S. E., Fox, A. & Vancampfort, D. 2015. Identifying the facilitators and processes which influence recovery in individuals with schizophrenia: a systematic review and thematic synthesis. *Journal of mental health*, 24, 103-10.
- Stuart, G. W. 2013. *Principles and practice of psychiatric nursing* Canada, Mosby Elsevier.
- Stuart, G. W. & Laraia, M. T. 2005. *Principles and practice of psychiatric nursing*, Philadelphia USA, Elsevier Mosby.
- Sunaryo dan Ronald. (2019). Pengaruh faktor psikosial dengan kekambuhan pasien skizofrenia di wilayah puskesmas Tepus 1 Gunung Kidul.
- Sutopo, A., Arthati, D. F., & Rahmi, U. A. 2014. *Kajian indikator lintas sektor kajian indikator sustainable development goals (SDGs)*. Jakarta. Badan Pusat Statistik.

- Townsend, M. C. 2014. *Essentials of Psychiatric Mental Health Nursing Concepts of Care in Evidence-Based Practice*, Philadelphia, F. A. Davis Company.
- Videbeck, S. L. (ed.) 2008. *Buku ajar keperawatan jiwa*, Jakarta: EGC.
- Wahyuni, S.D. (2019). Tugas Kesehatan Keluarga dalam Penanganan Kasus Kesehatan. Indonesian Journal of Community Health Nursing (Jurnal Keperawatan Komunitas). Vol 4, No. 1 Februari 2019.
- WHO. 2003. *The world health report* [Online]. Available: <http://www.who.int/whr/2003/chapter1/en/index3.html> [Accessed 27 Agustus 2016].
- Widianingsih, N. dan Astanto, S. (2020). Rehabilitasi psikososial sebagai upaya mencapai kemandirian bagi pasien gangguan jiwa skizofrenia (Studi di Rumah Sakit Marzuki Mahdi(RSMM) Bogor). Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol 17 No 1 Tahun 2020.
- Wood, L., Birtel, M., Alsawy, S., Pyle, M. & Morrison, A. 2014. Public perceptions of stigma towards people with schizophrenia, depression, and anxiety. *Psychiatry research*, 220, 604-8.
- Yosep, I. dan Sutini, T. (2015). Buku Ajar Keperawatan Jiwa dan Advance Mental Health Nursing. Bandung: Rafika Aditama.
- Yunitri, N.W, Kustanti, C.Y., dan Ashra, F. (2023). Psychotherapies for posttraumatic stress disorder applied for people in indonesia: A scoping review. Jurnal Keperawatan Padjadjaran. Vol. 11 No 1 (2023).

Glosarium

P

PTSD: *Post Traumatic Stress Disorder*

R

Recovery: adalah pemulihan

Total Recovered: pemulihan keseluruhan

Partially recovered: pemulihan sebagian

Unrecovered: belum mencapai pulih

Profil Penulis



Dr. Ns. Mamnu'ah, M.Kep., Sp.Kep. J.

Lahir di Indramayu, pada tahun 1973. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu dimulai dari Akademi Keperawatan di AKPER 'Aisyiyah Yogyakarta lulus tahun 1995. Selanjutnya menempuh S1 pada Program Studi Keperawatan, Universitas Gadjah Mada lulus tahun 2001. Pada tahun 2002 penulis selesai menempuh Pendidikan Profesi Ners di Universitas Gadjah Mada. Penulis melanjutkan

Pendidikan S2 Program Studi Keperawatan Jiwa pada Universitas Indonesia lulus tahun 2008 dan tahun 2010 lulus Spesialis Keperawatan Jiwa. Pendidikan S3 di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FKMK), Universitas Gadjah Mada lulus tahun 2019. Bekerja sejak tahun 1996 mulai dari AKPER sampai saat ini menjadi Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta (UNISA). Penulis mengampu mata kuliah Keperawatan Kesehatan Jiwa dan Psikososial, Keperawatan Psikiatri, Biostatistik, dan Metodologi Penelitian. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan sebagainya. Selain menjadi Dosen, penulis juga menjabat sebagai Ketua Pusat Studi Perempuan, Keluarga, dan Bencana (PSPKB) Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: mamnuah@unisayogya.ac.id

Motto: "Hidup mengalir seperti air."

Profil Penulis



Bdn. Dwi Ernawati, S.STT., M.Keb. Lahir di Bantul, pada tahun 1987. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu dimulai dari DIII Kebidanan STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta lulus tahun 2008. Selanjutnya menempuh DIV Pendidikan Bidan di STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta, lulus tahun 2010. Pada tahun 2016 penulis selesai menempuh pendidikan S2 Ilmu Kebidanan STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta. Penulis melanjutkan

Pendidikan Profesi bidan di Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, lulus tahun 2023. Bekerja sejak tahun 2008 sampai 2009 di RS Rajawali Citra, tahun 2009 sampai 2010 di Klinik Al Aman Godean, dan tahun 2010 sampai saat ini menjadi pengajar di Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: dwiernawati09@unisayogya.ac.id

Motto: "Berpegang pada Al Quran dan Sunah."

Profil Penulis



Dr. Yuli Isnaeni, SKp., M.Kep., Sp.Kom.

Lahir di Kulon Progo Yogyakarta, pada 23 Juli 1973. Pendidikan keperawatan ditempuh mulai dari Diploma III Keperawatan, yakni di Akademi Keperawatan Aisyiyah Yogyakarta, lulus tahun 1994, hingga saat ini ia mendedikasikan diri sebagai dosen di almamater tercinta, yang saat ini telah berubah menjadi Universitas Aisyiyah Yogyakarta. Pendidikan sarjana ditempuh di Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung, dan tercatat sebagai lulusan S1 Keperawatan UNPAD tahun 1999. Pendidikan Paska Sarjana dan Pendidikan Spesialis Keperawatan Komunitas ditempuh di Univeritas Indonesia, dinyatakan lulus Program Magister tahun 2007 dan lulus Program Spesialis tahun 2008. Pendidikan tingkat doktoral ditempuh di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dengan peminatan utama keperawatan komunitas kelompok khusus dan dinyatakan lulus S3 pada tahun 2023. Penulis dapat dihubungi melalui alamat email isnaenyuli@unisayogya.ac.id

Motto: “Life is worship”

SINOPSIS

Buku ini berisi tentang konsep skizofrenia, konsep *recovery*, dan instrument untuk mengukur tingkat *recovery* pasien skizofrenia di komunitas. Instrumen *recovery* terdiri dari 40 item yang menggambarkan indikator *recovery* pasien skizofrenia. Instrumen ini telah dilakukan uji validitas dan reliabilitas dan dinyatakan valid dan reliable. Instrumen ini dapat digunakan untuk mengukur tingkat *recovery* pasien skizofrenia di komunitas. Data tentang jumlah pasien skizofrenia yang sudah *recovery* belum ada, diharapkan dengan adanya instrument ini dapat digunakan untuk mengukur dan mengidentifikasi tingkat *recovery* pasien skizofrenia di komunitas.

Buku ini berisi tentang konsep skizofrenia, konsep recovery, dan instrument untuk mengukur tingkat recovery pasien skizofrenia di komunitas. Instrumen recovery terdiri dari 40 item yang menggambarkan indicator recovery pasien skizofrenia. Instrumen ini telah dilakukan uji validitas dan reliabilitas dan dinyatakan valid dan reliable. Instrumen ini dapat digunakan untuk mengukur tingkat recovery pasien skizofrenia di komunitas. Data tentang jumlah pasien skizofrenia yang sudah recovery belum ada, diharapkan dengan adanya instrument ini dapat digunakan untuk mengukur dan mengidentifikasi tingkat recovery pasien skizofrenia di komunitas.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919

ISBN 978-634-7139-57-3



9

786347

139573

